

Guide d'administration

Protocole *Irinotécan hebdomadaire*

Rédaction : Juin 2001

Révision : Mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du cancer colorectal métastatique chez des patients ayant progressé sur un traitement à base de fluorouracil¹.

ECOG 0-2 (18-65 ans)

ECOG 0-1 (>65 ans)

Visée palliative

Les patients à haut risque (âge avancé, irradiation pelvienne antérieure, fonction hépatique diminuée) qui pourraient ne pas tolérer l'administration aux 3 semaines d'irinotécan peuvent se voir offrir ce régime. Le risque de diarrhée est le même, mais le risque de neutropénie sévère pourrait être plus bas, la dose pouvant être ajustée plus précisément selon la tolérance du patient¹.

- › Évaluation de l'INESSS : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (Liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'irinotécan est administré une fois par semaine pendant 4 semaines suivi d'un repos de 2 semaines. La durée d'un cycle est de 42 jours.

En clinique externe jusqu'à progression, toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Irinotécan	125 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% en 90 minutes
<i>Répéter aux semaines pendant 4 semaines, suivi d'un repos de 2 semaines*</i>		

*Les traitements omis en raison de toxicités lors des semaines 1 à 4 peuvent être administrés les semaines 5 et 6 du même cycle, tant que le maximum de 4 traitements par cycle est respecté.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation :**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** potentiel émétique modéré (30-90%)²
 - Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
 - Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- › **Symptômes cholinergiques^{1,3} :**
 - Des symptômes cholinergiques tels que diaphorèse, salivation accrue, larmolement, bouffées vasomotrices ou crampes abdominales peuvent se manifester durant ou immédiatement après l'administration de l'irinotécan (dans les premières 24h). L'atropine 0,25-0,5 mg IV ou SC peut être administrée et répétée si besoin jusqu'à une dose totale de 1 mg. L'administration prophylactique est alors recommandée pour les traitements suivants. La tension artérielle et le rythme cardiaque doivent être surveillés.
- › **Surveillance des diarrhées¹ :**
 - Tous les patients doivent avoir en main une quantité suffisante de lopéramide accompagnée des instructions particulières à l'irinotécan : le patient doit débiter le lopéramide après la première selle molle ou peu consistante ou lorsque les selles sont plus fréquentes que d'habitude.
 - La posologie doit être bien expliquée : 4 mg immédiatement suivi de 2 mg aux 2 heures le jour (4 mg aux 4 heures la nuit). Cesser après 12h sans épisode de diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{1,3}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Irinotecan	Pas de recommandations en raison de l'absence de données pharmacocinétiques sur l'innocuité chez les patients atteints d'insuffisance rénale.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,3}

Médicament	Bilirubine (μmol/L)		AST/ALT	Ajustement posologique recommandé
Irinotecan	< 17	et	normaux	100 % de la dose d'irinotecan
	17-35	et	≤ 3 x LSN sans métas hépatique	Risque de neutropénie augmenté Considérer réduction de dose
			≤ 5 x LSN avec métas hépatique	
	> 35	et/ou	> 3 x LSN sans métas hépatique	Utilisation non recommandée*
			> 5 x LSN avec métas hépatique	Utilisation non recommandée*

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées⁴.

3.3. Niveaux de dose¹

Médicament	Dose de départ	Niveau - 1	Niveau - 2**
Irinotecan	125 mg/m ²	100 mg/m ²	75 mg/m ²

**Les doses peuvent être diminuées jusqu'à 50 mg/m².

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Grade	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)		Plaquettes (X10 ⁹ /L)	En cours de cycle	Au début d'un cycle	
1	≥ 1,5	OU	≥ 75	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	Le cycle peut débuter lorsque les neutrophiles sont ≥ 1,5 et les plaquettes ≥ 100. Sinon, il faut retarder le traitement et faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC. Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, il faut le cesser.
2	1,0-1,49	OU	50-74	Diminuer de 1 niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	
3	0,5-0,99	OU	25-49	Omettre la dose et diminuer de 1 niveau de dose lorsque résolu à ≤ grade 2	Diminuer de 1 niveau de dose	
4	< 0,5	OU	< 25	Omettre la dose et diminuer de 2 niveaux de dose lorsque résolu à ≤ grade 2	Diminuer de 2 niveaux de dose	
En cas de fièvre neutropénique, diminuer de 2 niveaux de dose et envisager le filgrastim selon le contexte clinique.						

*Utiliser la version la plus récente de l'échelle CTCAE

3.5. Ajustement des doses d'irinotécan en cas de diarrhée¹

Grade	Diarrhée	En cours de cycle	Au début d'un cycle	
1	Augmentation de 2-3 selles par jour, ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle.
2	Augmentation de 4-6 selles, ou selles nocturnes ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Diminuer de 1 niveau de dose	Maintenir le niveau de dose (si la diarrhée est la seule toxicité de grade 2)	
3	Augmentation de 7-9 selles par jour ou incontinence : malabsorption, augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Omettre la dose et diminuer de 1 niveau de dose lorsque résolu à $\leq$ grade 2	Diminuer de 1 niveau de dose (si la diarrhée est la seule toxicité de grade 3)	Réduire la dose selon le niveau de toxicité le plus élevé rencontré au cours du cycle précédent.
4	Augmentation de 10 ou plus selles par jour ou diarrhées sanguinolentes ou selles liquides sanguinolentes dans le sac de colostomie ou volume de selles liquides nécessitant un support parentéral; déshydratation	Omettre la dose et diminuer de 2 niveaux de dose lorsque résolu à $\leq$ grade 2	Diminuer de 2 niveaux de dose	Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, il faut envisager de cesser le traitement.

*Utiliser la version la plus récente de l'échelle CTCAE

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique¹

Grade*	En cours de cycle**	Au début d'un cycle**	
1	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle.
2	Diminuer de 1 niveau de dose	Diminuer de 1 niveau de dose	
3	Omettre la dose et diminuer de 1 niveau de dose lorsque résolu à $\leq$ grade 2	Diminuer de 1 niveau de dose	Réduire la dose selon le niveau de toxicité le plus élevé rencontré au cours du cycle précédent.
4	Omettre la dose et diminuer de 2 niveaux de dose lorsque résolu à $\leq$ grade 2	Diminuer de 2 niveaux de dose	Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, il faut envisager de cesser le traitement.

*À l'exception de l'alopecie, anorexie et asthénie.

** Utiliser la version la plus récente de l'échelle CTCAE

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** peut être dose limitante. Par ailleurs, les patients ayant subi une irradiation pelvienne antérieure présentent un risque de myélosuppression augmenté. Un suivi serré est recommandé¹.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et nécessitent une prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **diarrhée** peut être dose limitante. Ne pas administrer aux patients ayant des problèmes intestinaux ou des maladies inflammatoires de l'intestin ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Lors de l'instauration de la chimiothérapie, certains facteurs prédisposent le patient à un risque accru de diarrhée retardée de grade 3 ou 4. Ces facteurs sont : l'état de performance (OMS), le taux de globules blancs au début du traitement, la créatinine sérique élevée, le temps écoulé depuis la dernière progression sur fluorouracil et l'irradiation pelvienne antérieure^{1, 5}.

L'**alopécie** est fréquente¹.

Administrer avec prudence en cas de **maladie de Gilbert** (glucuronidation anormale de la bilirubine, dépistage par la mesure de la bilirubine directe et indirecte est recommandé)¹.

L'irinotécan est **irritant** lors d'extravasation⁶.

Tableau des principaux effets indésirables¹

Effets indésirables n=304	Grade 3 et 4 (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Diarrhée retardée	30,6	16,4	14,1
Vomissements	12,5	-	-
Nausées	16,8	-	-
Anorexie	5,9	-	-
Stomatite	0,7	-	-
Neutropénie	-	14,8	11,5

4.2. Interactions cliniques significatives

L'**irinotecan** est métabolisé par les carboxyl estérases en SN-38, un métabolite actif. L'irinotecan est également un substrat majeur du CYP450 3A4, de la glycoprotéine P et de l'UGT1A1. Le métabolite actif de l'irinotecan, le SN-38, est glucuronidé en un composé inactif¹⁻³.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Aprépitant	Irinotecan	↑ possible des concentrations d'irinotecan par inhibition modérée du CYP450 3A4.	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Irinotecan	↓ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de l'irinotecan pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Irinotecan	↑ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose d'irinotecan.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Irinotecan	↑ des concentrations plasmatiques de l'irinotecan par inhibition de son métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Irinotecan	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Irinotecan	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes
Avant chaque cycle (Maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes
Avant chaque traitement (Maximum 24 heures avant)	FSC, (AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline selon le contexte clinique)

5. Références

1. Pfizer Canada Inc. Monographie de irinotécan (Camptosar). Kirkland, Québec. Décembre 2014.
2. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
3. Irinotecan. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016)
4. Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of Chemotherapy. Semin Oncol 2006; 33(1): 50-67.
5. Vanhoefer U, Harstrick A, Achterrath W, Cao S, Seeber S, Rustum YM. Irinotecan in the treatment of colorectal cancer : a clinical overview. J Clin Oncol 2001; 19(5): 1502-18.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf